

“Espacios de Lactancia”: Satisfacción y experiencia de uso como espacios seguros, cómodos y privados en establecimientos de salud urbanos de Lima Metropolitana, La Libertad y Piura, 2025

Resumen de protocolo

Elemento	Descripción resumida
Tipo de estudio	Evaluación operativa, no experimental, transversal, multicéntrica, enfoque mixto (cuantitativo–cualitativo).
Población	Madres, padres y cuidadores que acuden con lactantes 0–23 meses a establecimientos con Espacios de Lactancia en Lima Metropolitana, La Libertad y Piura; personal de salud vinculado a la estrategia.
Muestra cuantitativa	≈392 encuestas (escenario recomendado: 95% IC, $d=\pm 7$ p.p., DEFF=1.8, 10% no respuesta), distribuidas proporcionalmente por establecimiento y franja horaria.
Muestra cualitativa	15–30 entrevistas a personal de salud y 4–6 grupos focales con cuidadores (6–8 participantes c/u), por saturación teórica y diversidad territorial.
Variable dependiente	Satisfacción y experiencia de uso: satisfacción global (Likert 1–5), recomendación del EL y uso del EL durante la visita (sí/no).
Variables independientes	Implementación del Espacio de Lactancia: disponibilidad/accesibilidad; condiciones del entorno (ESCP: seguridad, comodidad, privacidad); calidad del proceso (consejería breve, trato digno, ausencia de interrupciones); fidelidad (protocolos, responsable, dotación, limpieza, señalización). Variables de equidad: edad del lactante, condición migratoria, lengua, discapacidad, territorio, franja horaria.
Objetivo general	Describir y analizar la satisfacción y experiencia de uso de los Espacios de Lactancia como entornos seguros, cómodos y privados en establecimientos de salud urbanos de Lima Metropolitana, La Libertad y Piura (2025), e identificar factores asociados al uso.
Principales técnicas	Encuesta estructurada de salida (satisfacción/uso/experiencia); observación estructurada del EL (checklist ESCP); entrevistas semiestructuradas y grupos focales. Análisis: descriptivo y asociativo (χ^2 , t/Mann-Whitney; modelos logísticos con errores robustos por establecimiento) + análisis temático y triangulación.
Periodo de ejecución	Agosto – diciembre 2025 (pilotaje, levantamiento, análisis y reporte).
Resultados esperados	Evidencia para estandarizar y optimizar la implementación de los espacios, protocolos operativos y recomendaciones de mejora y escalamiento con enfoque de equidad.
Ética	Riesgo mínimo; consentimiento informado, confidencialidad, salvaguardas para NNA; no se entrevista ni observa directamente a NNA; aprobación CIEI y autorizaciones institucionales (DIRIS/DIRESAs).

“Espacios de Lactancia”: Satisfacción y experiencia de uso como espacios seguros, cómodos y privados en establecimientos de salud urbanos de Lima Metropolitana, La Libertad y Piura, 2025

1. Planteamiento del problema

La lactancia materna es una de las intervenciones más costo-efectivas en salud pública. Su inicio precoz, la lactancia materna exclusiva (LME) durante los seis primeros meses y su continuación hasta los dos años o más contribuyen a reducir la morbilidad infantil, mejorar el desarrollo cognitivo y proteger la salud materna frente a enfermedades crónicas como cáncer de mama, ovario y diabetes tipo 2 (WHO, 2023a; Victora et al., 2016; Rollins et al., 2016). Estas prácticas son reconocidas como estándar programático de salud pública en la primera infancia.

A nivel global, la LME alcanzó 48 % en 2023, todavía por debajo de la meta del 50 % establecida para 2025, con un inicio temprano cercano al 46 %, lo que evidencia brechas críticas en la atención perinatal (UNICEF & WHO, 2023). En el Perú, la cobertura de LME en menores de seis meses se redujo de 69,3 % en 2023 a 67,4 % en 2024, con diferencias marcadas entre el ámbito rural (78,3 %) y el urbano (65,5 %) (INEI, 2024; INEI, 2025). Estas brechas, vinculadas a obstáculos estructurales y organizativos en zonas urbanas, justifican focalizar la evaluación en Lima Metropolitana, La Libertad y Piura, regiones con alta demanda de servicios de salud.

El costo de no amamantar es elevado: se estiman alrededor de 595 000 muertes infantiles atribuibles a prácticas subóptimas cada año y pérdidas económicas globales por US\$ 341 000 millones anuales, asociadas a menor desarrollo cognitivo y mayores gastos en salud (Walters et al., 2019; WHO, 2023c). En el Perú, la persistencia de anemia y desnutrición infantil refuerza la necesidad de fortalecer la promoción de la lactancia en los servicios de salud (MINSA, 2023; UNICEF Perú, 2024).

Las causas inmediatas de estas brechas incluyen la infraestructura deficiente en los establecimientos de salud —ausencia de biombos o separadores, mobiliario

inadecuado, lavabos o refrigeración exclusiva para leche— así como la baja frecuencia de consejería breve, limitada por restricciones de tiempo y capacitación del personal (WHO, 2017; WHO & UNICEF, 2018; MIMP, 2021). A nivel estructural, la interferencia comercial de sucedáneos de la leche materna y la débil gobernanza del marco normativo obstaculizan la sostenibilidad y calidad de los espacios destinados a lactancia (Topothai et al., 2024).

Estas limitaciones generan menor inicio temprano de la lactancia, reducen la LME en los primeros seis meses y afectan la continuidad hasta los 23 meses, con repercusiones directas en salud pública y productividad futura (Victora et al., 2016; Walters et al., 2019).

En este escenario, los Espacios de Lactancia (EL) se definen como ambientes seguros, cómodos y privados dentro de establecimientos de salud, adaptados a los estándares nacionales (Ley N.º 29896 y su reglamento) e internacionales (OMS/UNICEF, BFHI). Los EL integran cuatro componentes esenciales —entorno seguro, condiciones higiénicas, comodidad y privacidad— junto con la conservación adecuada de la leche y la consejería breve en lactancia incorporada al flujo de atención (MIMP, 2021; WHO, 2017).

Si bien existen evidencias sobre apoyos a la lactancia en hospitales y entornos laborales, la literatura evaluativa sobre EL en salas de espera y servicios ambulatorios es escasa, en particular en América Latina. Esta brecha justifica la necesidad de generar evidencia sobre la satisfacción y experiencia de uso de los EL en condiciones reales, midiendo su contribución a la experiencia usuaria, el uso efectivo del servicio y los resultados inmediatos de lactancia. Desde un enfoque de investigación operativa, se aplicará el marco de implementation outcomes (aceptabilidad, adopción, fidelidad, sostenibilidad) como complemento a los resultados de usuario, con el fin de producir evidencia aplicable a la política pública y la gestión en salud (Proctor et al., 2011; Peters et al., 2013).

Pregunta de investigación:

¿Cuál es el nivel de satisfacción y experiencia de uso de los Espacios de Lactancia (EL) en establecimientos de salud urbanos de Lima Metropolitana, La Libertad y Piura, y qué factores de implementación (ESCP, accesibilidad, señalización, gestión y trato) se asocian con una mayor satisfacción y con el uso del espacio durante la visita?

2. Justificación

La lactancia materna (LM) es reconocida como una de las intervenciones más costo-efectivas para reducir morbilidad y mortalidad infantil, al mismo tiempo que favorece el desarrollo cognitivo y protege la salud materna frente a enfermedades

crónicas (Victora et al., 2016; WHO, 2023). En consecuencia, la OMS y UNICEF recomiendan la lactancia materna exclusiva (LME) durante los seis primeros meses de vida y su continuación hasta los dos años o más, acompañada de alimentación complementaria adecuada.

En el Perú, la LME alcanzó 69,3 % en 2023 y descendió a 67,4 % en 2024, con importantes diferencias territoriales: la prevalencia es mayor en áreas rurales y en la Sierra y Selva, mientras que en la Costa y zonas urbanas—incluyendo Lima Metropolitana, La Libertad y Piura— los indicadores tienden a estar por debajo del promedio nacional (INEI, 2024; INEI, 2025). Estas brechas geográficas reflejan desigualdades en el acceso a condiciones adecuadas para amamantar y justifican la focalización en contextos urbano-costeros.

Un cuello de botella operativo persistente es la falta de ambientes seguros, cómodos y privados para amamantar o extraer leche en los establecimientos de salud. Aunque la Ley N.º 29896 y su Reglamento (D.S. 023-2021-MIMP) establecen estándares para lactarios institucionales, su aplicación se concentra en espacios laborales y no contempla explícitamente las salas de espera ni los servicios comunitarios. A su vez, lineamientos internacionales como la *Operational Guidance on Infant and Young Child Feeding in Emergencies (OG-IFE v3)* recomiendan habilitar espacios protectores para lactancia en contextos de vulnerabilidad y alta movilidad, lo que resulta especialmente pertinente en los territorios priorizados.

Evaluar la satisfacción y experiencia de uso de los Espacios de Lactancia (EL) permitirá generar evidencia aplicada sobre la calidad percibida del servicio (seguridad, comodidad, privacidad, trato y gestión), así como identificar barreras y oportunidades de mejora para estandarizar y optimizar su implementación en los servicios de salud.

1. Establecer estándares mínimos y protocolos verificables para la implementación y monitoreo de EL en servicios de salud.
2. Fortalecer la articulación con el marco normativo nacional y con el Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna.
3. Generar evidencia útil para orientar decisiones de escalamiento programático, considerando principios de ética, equidad y salvaguarda de derechos.

De este modo, la investigación no solo busca documentar la pertinencia de los EL como estrategia de apoyo a la lactancia en entornos urbanos, sino también ofrecer insumos prácticos que fortalezcan políticas públicas y promuevan la equidad en salud materno-infantil.

3. Objetivos

3.1. Objetivo general

Evaluar la satisfacción y experiencia de uso de los Espacios de Lactancia implementados en establecimientos de salud de Lima Metropolitana, La Libertad y Piura en 2025, para valorar su calidad como entornos seguros, cómodos y privados durante la espera y proponer mejoras operativas.

3.2. Objetivos específicos

Caracterizar la disponibilidad, accesibilidad y nivel de uso de los Espacios de Lactancia entre cuidadores de lactantes (0–23 meses) durante el tiempo de espera en los servicios de salud.

Medir las condiciones de seguridad, comodidad y privacidad de los espacios mediante un índice compuesto (ESCP) y verificar la fidelidad de su implementación respecto a estándares nacionales e internacionales (protocolos, responsables, dotación, limpieza y señalización).

Evaluar la experiencia de las usuarias/os y la calidad del proceso en los Espacios de Lactancia, considerando consejería breve, trato digno, privacidad y satisfacción percibida.

Explorar, desde la perspectiva de las/os cuidadoras/es, en qué medida el EL facilita la lactancia durante la espera y qué recomendaciones proponen para mejorar su utilidad, accesibilidad y satisfacción usuaria.

4. HIPÓTESIS

4.1. Hipótesis General

Los Espacios de Lactancia que presentan mejores condiciones de seguridad, comodidad y privacidad (ESCP) y una gestión adecuada (señalización, accesibilidad, normas y trato) se asocian con mayor satisfacción de las/os cuidadoras/es y con mayor probabilidad de uso del espacio durante la visita.

4.2. Hipótesis Específicas

Se espera encontrar niveles altos de satisfacción y recomendación del EL; y que el mayor cumplimiento del ESCP (observado y percibido) y una mejor información/gestión del espacio se asocien con mayor satisfacción y uso.

5. VARIABLES DEL ESTUDIO

En este estudio se consideran variables dependientes e independientes, en concordancia con los objetivos e hipótesis planteados. Su definición operativa busca

caracterizar el desempeño de los Espacios de Lactancia (EL) como entornos seguros, cómodos y privados, así como su contribución a la promoción de la lactancia materna en lactantes de 0–23 meses.

5.1. Variable dependiente

Definición operativa: nivel de satisfacción y experiencia de uso reportado por las/os cuidadoras/es al interactuar con el Espacio de Lactancia durante su visita (satisfacción global, recomendación y uso del EL).

Dimensiones, indicadores e instrumentos:

- Uso del Espacio de Lactancia durante la visita (sí/no). Escala: dicotómica. Instrumento: encuesta de salida.
 - o (Satisfacción global con el Espacio de Lactancia. Escala: Likert 1–5. Instrumento: encuesta de salida.
 - o Recomendación del Espacio de Lactancia (disposición a recomendar / NPS). Escala: Likert 1–5 o 0–10; NPS –100 a 100. Instrumento: encuesta de salida.

5.2. Variables independientes

Estrategia “Espacios de Lactancia”.

Definición operativa: intervención que habilita un entorno seguro, cómodo y privado dentro del establecimiento de salud, con consejería breve integrada al flujo de atención.

Dimensiones, indicadores e instrumentos:

- **Condiciones ESCP percibidas (seguridad, comodidad y privacidad):** sentirse segura/o, disponer de privacidad efectiva, mobiliario adecuado, ventilación/temperatura apropiada.
 - o Indicadores: puntajes escalares (0–10 o 1–5); proporción de interrupciones no deseadas.
 - o Instrumentos: encuesta de salida + checklist de observación.
- **Acogida emocional y trato digno:** percepción de respeto, amabilidad y ausencia de maltrato.
 - o Indicadores: escala Likert (1–5 / 0–10).
 - o Instrumentos: encuesta; entrevistas; grupos focales.
- **Calidad y pertinencia de la consejería:** verificación de agarre/posición, resolución de dificultades, transmisión de mensajes clave.
 - o Indicadores: % que recibe los tres componentes.
 - o Instrumentos: observación + encuesta; entrevistas.
- **Pertinencia cultural del servicio:** adecuación a idioma y contexto migrante/comunidad de acogida.
 - o Indicadores: ítems de adecuación cultural.
 - o Instrumentos: encuesta; grupos focales.

- **Perspectiva del personal de salud:** percepciones sobre funcionamiento, barreras y facilitadores.
 - o Indicadores: categorías temáticas.
 - o Instrumentos: entrevistas al personal.

Índice ESCP.

Se utilizará el **Índice del Espacio Seguro, Cómodo y Privado (ESCP)** para evaluar la calidad de los espacios:

- **Definición:** escala compuesta (0–100) que resume el grado en que el EL cumple estándares mínimos durante la espera de atención.
- **Estructura:** tres subíndices (0–100):
 - o **Seguridad:** control básico de riesgos, limpieza, iluminación, manejo de residuos.
 - o **Comodidad:** mobiliario adecuado, cambiador, ventilación/temperatura, superficie de apoyo.
 - o **Privacidad:** barreras visuales/acústicas, control de aforo, ausencia de interrupciones no deseadas.
- **Medición:** cada ítem se califica como **1 = cumple** / **0 = no cumple**; los subíndices corresponden al porcentaje de ítems cumplidos y el ESCP es el promedio de los tres.
- **Punto de corte:** desempeño adecuado definido como **ESCP $\geq$ 80** y cada subíndice $\geq$ 75.

6. Matriz de Operacionalización de Variables

La Matriz de Operacionalización de Variables presentada a continuación detalla las variables clave del estudio, su definición conceptual, dimensiones específicas, indicadores, preguntas orientadoras, escalas de medición y los instrumentos que se utilizarán para garantizar coherencia metodológica y rigor técnico.

Variable	Definición	Dimensión	Indicador	Ítem	Escala	Instrumento
Variable Independiente: Estrategia “Espacios de Lactancia”	Intervención comunitaria que brinda espacios seguros y atención sobre lactancia materna para madres en contextos humanitarios urbanos.	Seguridad percibida	Nivel de seguridad del espacio según percepción del usuario	¿Se siente segura(o) en el “Espacios de Lactancia”?	Likert	Encuesta
		Acogida emocional	Nivel de comodidad y confianza con el personal	¿Se siente escuchada y respetada?	Likert	Encuesta / Entrevista
		Pertinencia cultural	Adecuación del servicio al contexto migrante y cultural	¿La información fue brindada en su idioma o con enfoque cultural adecuado?	Categorica	Encuesta / Grupo Focal
Variable	Definición	Dimensión	Indicador	Ítem	Escala	Instrumento
Variable Dependiente: Satisfacción y experiencia de uso del EL	Nivel de satisfacción y experiencia usuaria con el Espacio de Lactancia, incluyendo recomendación y percepción de utilidad durante la visita.	Conocimiento	Cambios en conocimientos sobre lactancia materna	¿Qué beneficios conoce de la lactancia?	Categorica	Encuesta Pre / Post
		Práctica	Inicio temprano y duración de lactancia	¿Amamantó a su bebé en la primera hora de nacido? ¿Cuántos meses dio lactancia?	Categorica	Encuesta
		Satisfacción	Nivel general de satisfacción con el	¿Qué tan satisfecha está con el espacio?	Likert	Encuesta / Entrevista

			servicio			
--	--	--	----------	--	--	--

7. DISEÑO METODOLÓGICO

7.1. Tipo de estudio:

Estudio no experimental, transversal y descriptivo-analítico con enfoque mixto. Es no experimental porque no se manipulan variables; transversal porque la medición se realiza en un periodo definido de 2025; y analítico porque explora asociaciones entre la implementación del EL (ESCP, accesibilidad/gestión) y los resultados de satisfacción/uso.

7.2. Enfoque metodológico:

Mixto convergente. Se recolectan y analizan, en paralelo, datos cuantitativos (encuesta de salida y checklist observado del espacio) y cualitativos (entrevistas y/o grupos focales). Luego se triangulan hallazgos para fortalecer validez y orientar recomendaciones prácticas.

7.3. Ámbito geográfico:

Establecimientos de salud con Espacios de Lactancia implementados en Lima Metropolitana, La Libertad y Piura (2025). El detalle de sedes se definirá con los espacios implementados activos de los establecimientos de salud.

7.4. Población y Muestra:

Población cuantitativa: madres, padres y cuidadores que acuden con lactantes de 0–23 meses y utilizan/visitan el Espacio de Lactancia durante la espera de la atención.

Población cualitativa: personal de salud vinculado a la estrategia (responsables de consejería/gestión del espacio) y cuidadores usuarios/as.

Unidad de análisis (encuesta): cuidador/a que reporta su experiencia de uso (o no uso) del EL, su satisfacción, recomendación, percepciones ESCP y barreras/facilitadores durante la visita.

Unidades de observación (checklist): establecimientos implementados activos.

Diseño muestral (componente cuantitativo)

Muestreo por conglomerados en dos etapas:

- **Conglomerado primario:** *establecimiento implementado.*
- **Selección en campo:** muestreo por tiempo-lugar con selección consecutiva de cuidadores que acuden con lactantes (0–23 m) y aceptan participar, hasta completar la cuota por establecimiento de salud

Tamaño de muestra (encuesta a cuidadores)

Se utilizará una estrategia de muestreo probabilístico por conglomerados bietápico, considerando:

- Primer nivel de conglomeración: cada establecimiento de salud es una unidad primaria de muestreo.
- Segundo nivel: dentro de cada establecimiento, se seleccionará de forma aleatoria sistemática a los cuidadores que acuden a atenciones durante los días de trabajo de campo, hasta alcanzar el tamaño de muestra requerido.

Para el cálculo del tamaño de muestra se considera:

- Base (proporción, muestreo aleatorio simple):

$$n_0 = Z_{1-\alpha/2}^2 p(1-p)/d^2$$
- Ajuste por diseño: $n_1 = n_0 \times DEFF$
- Ajuste por no respuesta: $n = n_1/(1-r)$
- (Opcional) Corrección por población finita si se conoce N: $n_f = \frac{n}{1+\frac{n-1}{N}}$

Donde:

$$Z = 1.96 \text{ (95\%)}, p = 0.50, d = 0.07, DEFF = 1.8, r = 10\%$$

$$\rightarrow n_0 = 196; n_1 = 353; n \approx 392 \text{ encuestas (total estudio).}$$

Componente cualitativo

Para abordar integralmente los factores internos y externos que inciden en el funcionamiento de los Espacios de Lactancia como entornos seguros, cómodos y privados durante la espera, y en su contribución a la promoción de la lactancia materna, se complementará el componente cuantitativo con un componente cualitativo de corte explicativo. Este componente permitirá profundizar en percepciones, prácticas y procesos que no son capturados plenamente por los indicadores cuantitativos.

Este componente se desarrollará mediante entrevistas semiestructuradas y grupos focales aplicados a actores clave:

- **Personal de salud:** profesionales directamente vinculados a la implementación y operación de los Espacios de Lactancia y a la consejería IYCF (enfermería, obstetricia, nutrición, medicina, psicología), así como jefaturas o responsables del establecimiento.
- **Madres, padres o cuidadores principales:** personas que asisten con lactantes (0–23 meses) y **utilizan o visitan** el Espacio de Lactancia durante la

espera, procurando diversidad por territorio, horario, condición migratoria y paridad.

Se proyecta realizar entre 15 **entrevistas** a personal de salud, distribuidas entre los establecimientos priorizados (aprox. **1 a 2 profesionales por establecimiento**), y **5 grupos focales** con cuidadores, con **6 a 8 participantes** cada uno, organizados por territorio y disponibilidad. El **tamaño de la muestra cualitativa** se ajustará según el **criterio de saturación teórica**, garantizando la cobertura de perspectivas diversas y la identificación de **categorías relevantes** para explicar facilitadores y barreras del funcionamiento de los Espacios de Lactancia.

Como **técnica de análisis**, se empleará un **Análisis de Determinantes del desempeño** de los Espacios de Lactancia, inspirado en marcos de determinantes sociales de la salud, que organizará los hallazgos en tres niveles:

- **Determinantes estructurales:** situación socioeconómica y laboral de los cuidadores, migración, género y cargas de cuidado.
- **Determinantes intermedios (organizacionales y de acceso):** accesibilidad física, horarios y señalización del espacio, dotación e insumos, tiempos de espera, coordinación con otros servicios (CRED, vacunación, suplementación), protocolos y responsabilidades, mecanismos de derivación y de quejas/sugerencias, y condiciones de seguridad.
- **Determinantes próximos (experiencia y proceso):** percepción de seguridad, comodidad y privacidad del EL; trato digno; pertinencia cultural/idioma; información y apoyo recibido; satisfacción con el servicio; barreras/facilitadores y disposición a usar/recomendar el EL.

La información recopilada se analizará mediante análisis temático y se triangulará con los hallazgos cuantitativos, con el fin de fortalecer la interpretación de resultados y proponer recomendaciones prácticas para optimizar la implementación, el uso y la sostenibilidad de los Espacios de Lactancia.

7.5. Criterios de Inclusión

- Persona adulta cuidadora que asiste con lactante (0–23 m) y utiliza/visita el espacio
- Acepta y firma/otorga consentimiento informado.

7.6. Criterios de Exclusión

- Rechaza participar

- Presenta malestar/urgencia clínica o emocional que impida participar con seguridad.

7.7. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos

Para alcanzar los objetivos de la investigación y responder la pregunta central, se utilizará una estrategia de recolección combinada, que integra métodos cuantitativos y cualitativos bajo un enfoque mixto de triangulación.

Componente cuantitativo

El componente cuantitativo se desarrollará mediante encuestas estructuradas a madres, padres o cuidadores que acuden con lactantes (0–23 meses) a los Espacios de Lactancia durante la espera de la atención en los establecimientos de salud priorizados de Lima Metropolitana, La Libertad y Piura.

Las encuestas incluirán ítems cerrados y escalas validadas organizadas en secciones para recolectar información sobre:

- **Datos sociodemográficos** básicos del cuidador (edad, sexo, parentesco, nivel educativo, ocupación; y variables de equidad como condición migratoria, lengua y discapacidad).
- **Características de la visita y uso del espacio** (motivo de la visita, tiempo de espera, si usó el espacio y para qué: amamantar, extracción, cambio de pañal; tiempo de uso).
- **Percepción del entorno: seguridad, privacidad y comodidad** (escalas Likert/0–10), **trato digno, satisfacción y NPS**.
- **Consejería breve en LM** recibida durante la espera (componentes clave y oportunidad).
- **Satisfacción y experiencia de uso del EL: satisfacción global, recomendación, uso (sí/no), percepciones ESCP, barreras y sugerencias**.
- **Prácticas auto-reportadas de LM** (LME <6 m; continuidad 6–23 m) y **barreras** percibidas para el cuidado durante la espera.

Además, se aplicarán un instrumento complementario:

Observación estructurada del espacio (checklist ESCP).

Se aplicará un checklist para medir Seguridad, Comodidad y Privacidad del espacio y registrar interrupciones, señalización y limpieza. Cada ítem se califica cumple/no cumple (1/0). Con estos datos se calcularán los subíndices por dimensión (0–100) y el ESCP total (promedio de subíndices). Para capturar la variación operativa, se realizarán observaciones en múltiples franjas horarias y días (sugerencia operativa: 3 días × 3 franjas por establecimiento). Se documentarán eventos críticos/veto (p. ej., ausencia de barrera de privacidad o

riesgo eléctrico), que marcarán el caso como no conforme aun si el puntaje global fuera alto.

La encuesta será pilotada en un establecimiento de características similares para verificar comprensión, tiempos y consistencia lógica, realizando los ajustes necesarios antes de su aplicación definitiva. La recolección se efectuará con encuestadores capacitados, quienes registrarán respuestas en dispositivos móviles o formularios impresos (según disponibilidad), con controles de calidad (supervisión, revisión diaria y re-contacto muestral).

Componente cualitativo

El componente cualitativo se ejecutará mediante entrevistas semiestructuradas y grupos focales con actores clave:

- **Entrevistas semiestructuradas (personal de salud):** profesionales responsables de la implementación y operación de los Espacios de Lactancia y de la consejería en LM (enfermería, obstetricia, nutrición, medicina, psicología, jefaturas). Las entrevistas profundizarán percepciones y criterios operativos sobre organización del espacio, disponibilidad de recursos, tiempos de espera, calidad y oportunidad de la consejería, articulación con otros servicios (CRED, vacunación, suplementación), mecanismos de protección y derivación, barreras/facilitadores y propuestas de mejora.
- **Grupos focales (madres, padres o cuidadores):** para explorar motivaciones de uso, experiencias en términos de seguridad/privacidad/comodidad, trato y satisfacción, barreras (económicas, logísticas, culturales), pertinencia cultural/idioma, redes de apoyo y decisiones relacionadas con la lactancia durante la espera. Cada grupo reunirá 6–8 participantes, considerando diversidad territorial y socioeconómica.

Para ambos instrumentos se elaborarán guías de entrevista y de grupo focal, validadas internamente, con preguntas abiertas, subpreguntas de sondeo y temas eje alineados a los objetivos específicos, a fin de asegurar coherencia y comparabilidad y facilitar la codificación y el análisis.

Las entrevistas y grupos focales se realizarán en espacios seguros, dentro o cerca de los establecimientos, con una duración aproximada de 45 a 90 minutos. Previo a cada sesión se solicitará consentimiento informado. Se contará con grabación de audio (con autorización) y notas de campo para reforzar la calidad de la información recolectada. Los hallazgos cualitativos serán analizados temáticamente y triangulados con la evidencia cuantitativa para fortalecer la

interpretación de resultados y proponer recomendaciones prácticas para optimizar la implementación y el uso de los Espacios de Lactancia.

7.8. Análisis Estadístico

Para responder a los objetivos de la investigación y contrastar las hipótesis planteadas, se realizará un análisis que combinará técnicas descriptivas e inferenciales, con integración cuantitativa–cualitativa bajo un enfoque de triangulación. Se utilizará software especializado SPSS para el componente cuantitativo y Matrices en Microsoft Excel para el cualitativo).

Análisis cuantitativo

Los datos de encuestas estructuradas y los registros de observación serán verificados mediante controles de calidad (rangos, saltos lógicos, duplicados) y procesados en programas estadísticos. Dado el diseño multicéntrico y por conglomerados (establecimientos implementados), los análisis incorporarán errores estándar robustos para el diseño y, cuando corresponda, ponderaciones por probabilidad/flujo.

Fase descriptiva. Se caracterizará a las/os cuidadoras/es y la experiencia de uso del Espacio de Lactancia:

- **Categorías:** frecuencias absolutas y relativas (%) para sexo, parentesco, nivel educativo, condición migratoria, lengua, discapacidad, uso del espacio (sí/no), recepción de consejería breve (sí/no), satisfacción (categorías), y semáforos programáticos.
- **Continuas/ordinales:** medias/medianas y dispersión para edad, tiempo de espera/uso, puntajes percepción de seguridad/privacidad/comodidad (0–10), y Índice ESCP (0–100) y subíndices.

Cálculo e interpretación del ESCP.

Se calcularán subíndices de Seguridad, Comodidad y Privacidad (0–100) y el ESCP total (0–100). Se reportarán medias/medianas e IC95%, comparaciones por territorio y tipo de establecimiento, y un “semáforo” de desempeño (verde ≥ 80 ; amarillo 60–79; rojo < 60). Para contrastar metas programáticas se usarán pruebas de una muestra (medias: t o Wilcoxon; proporciones de “cumple meta”: prueba z). Para explorar factores asociados a percepción alta ($\geq 8/10$) o uso del espacio, se podrán implementar modelos logísticos con errores robustos por clúster (establecimiento) y, de ser pertinente, modelos mixtos con intercepto aleatorio por sede.

Análisis cualitativo

Los audios de entrevistas y grupos focales serán transcritos literalmente y revisados para asegurar fidelidad. Se implementará un análisis temático con codificación abierta y axial, organizando hallazgos en torno a determinantes estructurales, intermedios (organizacionales y de acceso) y próximos (experiencia y proceso), con énfasis en categorías relacionadas con seguridad, privacidad, comodidad, trato digno, pertinencia cultural/idioma, calidad de la consejería y barreras/facilitadores para el uso del Espacio de Lactancia. Se generarán matrices de contenido por territorio y tipo de establecimiento para comparar patrones y variaciones.

Triangulación. Los resultados cualitativos se integrarán con la evidencia cuantitativa para explicar asociaciones y brechas detectadas, fortaleciendo la interpretación global y la formulación de recomendaciones.

Validación y control de calidad

Se realizarán revisiones de consistencia, detección de valores atípicos y verificación de supuestos antes de pruebas inferenciales. Para el checklist de observación, se evaluará concordancia interobservador en una submuestra; para escalas, consistencia. El análisis cualitativo será conducido por al menos dos analistas, con contraste interevaluador y resolución por consenso.

El conjunto de análisis permitirá responder sólidamente a las hipótesis, identificar áreas de mejora operativa y proponer estrategias prácticas para optimizar la implementación, el uso y la sostenibilidad de los Espacios de Lactancia en Lima Metropolitana, La Libertad y Piura.

8. Aspectos éticos

La presente investigación cumplirá estrictamente con los principios éticos universales de respeto, beneficencia, no maleficencia y justicia, establecidos en la Declaración de Helsinki y en las pautas éticas internacionales para investigaciones en salud.

Respeto a la autonomía y consentimiento informado

Se garantizará que todas las personas participantes (madres, padres, cuidadores y personal de salud) sean plenamente informadas sobre los objetivos, finalidad, procedimientos, duración aproximada, posibles beneficios y riesgos de la investigación. Antes de iniciar la aplicación de encuestas, entrevistas o grupos focales, se solicitará el consentimiento informado de forma verbal y/o escrita, de acuerdo con las directrices de los Comités Institucionales de Ética.

Los participantes podrán retirarse de la investigación en cualquier momento, sin que ello implique perjuicio alguno o limitación de su derecho a recibir atenciones de salud.

Confidencialidad y privacidad

Se resguardará la confidencialidad de la información obtenida. Los datos recolectados no incluirán nombres ni datos que permitan la identificación directa de los participantes. Cada encuestado o entrevistado será registrado mediante un código único anonimizado.

Toda la información recolectada se almacenará en bases de datos digitales protegidas con clave de acceso restringido a los miembros del equipo de investigación. Los archivos físicos (formularios, consentimientos firmados) se conservarán bajo custodia segura y serán destruidos de forma adecuada al concluir el estudio.

Riesgos y beneficios

El estudio se considera de riesgo mínimo, ya que no implica intervenciones invasivas ni procedimientos clínicos. El único riesgo potencial está asociado a la exposición de información personal; sin embargo, este será mitigado mediante el resguardo de la confidencialidad, espacios seguros para la recolección de información y lineamientos claros para la conducción de entrevistas y grupos focales.

Los posibles beneficios indirectos se relacionan con el aporte de información para mejorar la gestión de las atenciones de salud infantil en los establecimientos seleccionados, así como la formulación de estrategias para promover la permanencia y calidad de las atenciones para la primera infancia.

Cumplimiento normativo y autorización

El protocolo será sometido a revisión y aprobación por el Comité de Ética en Investigación correspondiente, cumpliendo los requisitos ético-legales establecidos. Asimismo, se gestionarán los permisos institucionales necesarios ante las Direcciones de Redes Integradas de Salud (DIRIS) de Lima Metropolitana y la Gerencia Regional de Salud (DIRESA) La Libertad y Piura.

En todo momento se respetarán las políticas de protección de poblaciones vulnerables, considerando que la población objetivo incluye niños y niñas menores de cinco años y sus familias. Por ello, la recolección de información se dirigirá

únicamente a los cuidadores responsables y personal de salud adulto, asegurando que no se exponga de manera directa a menores de edad.

Difusión y uso de resultados

Los hallazgos de la investigación se presentarán de forma agregada y anonimizada en informes finales, artículos o presentaciones académicas, sin incluir datos que puedan permitir la identificación de los participantes.

Se garantizará que la información generada sea utilizada exclusivamente con fines de mejora de la gestión de las atenciones de salud para la primera infancia y no para fines comerciales ni de otra índole.

9. Responsabilidades del equipo de investigación

El equipo de investigación estará conformado por profesionales con experiencia en salud pública, investigación operativa y análisis de programas de atención primaria. Cada miembro tendrá responsabilidades claramente definidas para garantizar el cumplimiento riguroso de cada fase del protocolo, desde el diseño metodológico hasta la presentación de resultados como se presenta en el siguiente cuadro:

Rol	Responsabilidad principal	Funciones específicas
Investigador Principal (IP)	Dirección y coordinación general del estudio	- Gestionar permisos y autorizaciones éticas e institucionales. - Validar y aprobar instrumentos de recolección. - Supervisar todas las fases: planificación, ejecución y cierre. - Coordinar reuniones con autoridades y actores clave. - Aprobar informes parciales y finales.
Co-investigadores/as	Apoyo técnico y metodológico	- Apoyar en diseño metodológico y validación de instrumentos. - Coordinar logística de campo. - Participar en supervisión del trabajo de campo. - Colaborar en análisis de datos cuantitativos y cualitativos. - Redactar reportes y validar resultados.
Coordinador/a de Trabajo de Campo	Organización operativa y supervisión directa	- Organizar cronograma de visitas a establecimientos. - Supervisar encuestadores/as y moderadores/as. - Verificar cumplimiento de protocolo ético. - Coordinar acceso a ES y logística local. - Monitorear avances y resolver incidencias.
Equipo de	Ejecución de la	- Aplicar encuestas estructuradas a cuidadores.

Encuestadores/as y Moderadores/as	recolección de datos	- Conducir entrevistas y grupos focales. - Garantizar calidad y veracidad de la información recolectada. - Respetar normas éticas y confidencialidad. - Reportar incidencias diarias al Coordinador/a de Campo.
Equipo de Procesamiento y Análisis	Digitación, limpieza y análisis de datos	- Digitar y validar la base de datos. - Ejecutar análisis estadístico descriptivo e inferencial. - Transcribir audios y sistematizar información cualitativa. - Elaborar matrices de análisis temático. - Triangular hallazgos cuantitativos y cualitativos.

10. Cronograma

Actividad / Fase	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo
1. Diseño final del protocolo y validación interna	●			
2. Presentación y aprobación por Comité de Ética				
3. Gestión de permisos institucionales (DIRIS/DIRESA)	●			
4. Elaboración y validación de instrumentos (encuestas, guías)	●			
5. Pilotaje de instrumentos y ajustes finales	●			
6. Capacitación del equipo de campo	●			
7. Recolección de datos cuantitativos	●	●		
8. Recolección de datos cualitativos (entrevistas / grupos focales)	●	●		
9. Procesamiento y análisis de datos cuantitativos		●	●	
10. Procesamiento y análisis de datos cualitativos		●	●	
11. Triangulación de resultados y elaboración de informe preliminar			●	
12. Revisión de hallazgos por comité técnico / validación			●	
13. Redacción de informe final de investigación			●	●
14. Presentación y socialización de resultados finales				●

Instrumento 1: Encuesta estructurada a cuidadores de lactantes

Actor al que está dirigido:

Madres, padres u otros cuidadores principales de niños y niñas de 0 a 23 meses que acuden a establecimientos de salud con Espacios de Lactancia (EL).

Propósito general:

Recoger información cuantitativa sobre conocimiento y uso del Espacio de Lactancia, percepción del entorno (ESCP), satisfacción/experiencia usuaria, barreras y facilitadores, y características sociodemográficas de las/os cuidadoras/es.

Variables que medirá:

1. Variables dependientes (VD):

- a. Uso del Espacio de Lactancia (Sí/No).
- b. Nivel de satisfacción con el EL (Likert 1–5).
- c. Eliminado: prácticas de lactancia como VD, para alinear el instrumento al enfoque en satisfacción/experiencia de uso.

2. Variables independientes (VI):

- a. Percepción de seguridad, comodidad y privacidad (Índice ESCP).
- b. Conocimiento de la existencia del EL.
- c. Experiencia de consejería recibida en el servicio.
- d. Barreras y facilitadores percibidos para el uso del EL.

3. Covariables sociodemográficas (CV):

- a. Edad, sexo, nivel educativo, ocupación, condición migratoria, número de hijos, tipo de seguro de salud, región y establecimiento de salud.

Encuesta estructurada a cuidadores de lactantes (0–23 meses)

M0. Identificación (solo para control – no leer)

I0. Código de encuesta: _____

I1. Región: 1=Lima Metropolitana / 2=La Libertad / 3=Piura

I2. IPRESS: _____

I3. Fecha (dd/mm/aaaa): //_____

I4. Hora inicio: / Hora fin:

I5. Encuestador/a (código): ____

M1. Elegibilidad y consentimiento

1. ¿Tiene a su cargo un(a) niño(a) de 0 a 23 meses? 1=Sí → continuar / 0=No → terminar
2. ¿Cuál es su edad? ____ años (si <18 → terminar)
3. ¿Acepta participar de forma voluntaria? (leer script breve) 1=Sí / 0=No → terminar

M2. Visita al servicio (contexto)

4. Motivo principal de la visita hoy: 1=CRED 2=Vacunación 3=Consulta
4=Trámite/adm. 5=Otro: _____
5. Tiempo de espera aproximado antes de la atención: ____ minutos (numérico)

M3. Conocimiento y uso del Espacio de Lactancia (VD/VI)

6. Antes de hoy, ¿sabía que este establecimiento tiene un Espacio de Lactancia (EL)?
1=Sí / 0=No
7. ¿Usó el Espacio de Lactancia hoy durante su visita? (VD1) 1=Sí / 0=No
8. (Si No en 7) ¿Cuál fue el motivo principal para no usarlo? (una opción) 1=No lo necesitó 2=No lo encontró 3=Estaba ocupado 4=Falta de tiempo 5=No le permitieron 6=No sabía que existía 7=Otro: _____
9. En visitas anteriores a esta IPRESS, ¿usó el EL? 0=Nunca 1=1–2 veces 2=3 o más

M4. Índice ESCP – Percepción usuaria (VI)

(Use escala Likert 1–5: 1=Totalmente en desacuerdo, 2=En desacuerdo, 3=Ni de acuerdo ni en desacuerdo, 4=De acuerdo, 5=Totalmente de acuerdo)

Seguridad

- 10. Percibí el ambiente limpio e higienizado. (S1)
- 11. La iluminación y la ventilación fueron adecuadas. (S2)
- 12. El acceso al EL fue seguro (señalización y accesibilidad). (S3)

Comodidad

- 13. El mobiliario fue adecuado para amamantar (silla/soporte). (C1)
- 14. La temperatura y el ruido del ambiente fueron confortables. (C2)
- 15. Encontré insumos de apoyo (lavamanos/agua, toallas, folletería). (C3)

Privacidad

- 16. Me sentí resguardada(o) de miradas externas. (P1)
- 17. Pude amamantar sin interrupciones del personal u otras personas. (P2)
- 18. La puerta/biombo/cortina brindó privacidad suficiente. (P3)

Puntuación ESCP: luego se recodifica 1-2→0; 3→1; 4-5→2 (para el índice mixto con checklist).

M5. Satisfacción con el EL (VD)

- 19. En general, ¿qué tan satisfecha(o) quedó con el EL? (VD2) 1=Muy insatisfecha(o)
2=Insatisfecha(o) 3=Neutral 4=Satisfecha(o) 5=Muy satisfecha(o)
- 20. Recomendaría el uso del EL a otras personas. 1=Totalmente en desacuerdo ...
5=Totalmente de acuerdo

M6. Consejería breve y apoyo

- 24. Hoy recibió consejería/apoyo en lactancia (en EL o servicio). 1=Sí / 0=No
- 25. (Si es Sí) ¿La consejería le ayudó a resolver dudas o afianzar la práctica?
1=Totalmente en desacuerdo ... 5=Totalmente de acuerdo

M7. Barreras y facilitadores (VI)

- 26. Principales barreras para usar el EL (puede marcar hasta 2): 1=Ubicación/lejos
2=Señalización insuficiente 3=Horario restringido 4=Aforo/ocupado
5=Falta de autorización 6=Falta de privacidad 7=Limpieza insuficiente 8=Otro: ____
- 27. Principales facilitadores (hasta 2): 1=Buena señalización 2=Privacidad 3=Personal atento 4=Limpieza/orden 5=Mobiliario adecuado 6=Material educativo 7=Otro: ____

M8. Sociodemográficos y servicio

- 28. Parentesco con el/la niño(a): 1=Madre 2=Padre 3=Abuela/o 4=Otro: ____
- 29. Sexo del participante: 1=Mujer 2=Hombre 3=Otro/Prefiere no decir
- 30. Edad del participante: ____ años
- 31. Nivel educativo: 0=Sin estudios 1=Primaria 2=Secundaria 3=Técnico
4=Universitario 5=Posgrado

32. Ocupación principal: 1=Ama/o de casa 2=Trabajo remunerado 3=Estudia
4=Desempleado 5=Otro: ____
33. Condición migratoria: 1=Peruano/a 2=Extranjero/a (país: ____)
34. N° de hijos vivos: ____
35. Seguro de salud: 1=SIS 2=EsSalud 3=Privado 4=FF.AA./PNP 5=Ninguno
36. Distrito/Provincia de residencia: _____
37. ¿Con quién acudió hoy? 1=Solo(a) 2=Pareja 3=Familiar 4=Amiga/o 5=Otro

M9. Cierre

38. ¿Desea agregar algún comentario o sugerencia para mejorar el Espacio de Lactancia? (Respuesta abierta)

Instrumento Cualitativo 1: Guía de Grupo Focal con cuidadores de lactantes (60 min)

Propósito: Explorar experiencias, percepciones y sugerencias sobre el uso (o no uso) de los Espacios de Lactancia (EL) y cómo estos refuerzan conocimientos y prácticas de lactancia; profundizar en Seguridad, Comodidad y Privacidad (ESCP).

Participantes: 6–8 cuidadores adultos (≥ 18 años) de niños/as 0–23 meses.

Composición: 2 GF por región → (A) usuarios del EL, (B) no usuarios o con barreras.

Duración: 60 min (máx. 75).

Registro: Audio con autorización; notas de campo.

Lugar: ambiente silencioso, sillas en semicírculo, agua/refrigerio.

Accesibilidad: baño cercano, espacio para coche del lactante.

Riesgo mínimo: permitir pausas, retiro libre, apoyo si hay malestar.

Protección de datos: códigos por participante; no recoger nombres reales en la grabación.

Instrumento Cualitativo 1: Guía de Grupo Focal con cuidadores de lactantes

1) Apertura (5–7 min)

- a. **Presentación y objetivo:** “Queremos conocer sus experiencias con los Espacios de Lactancia para mejorar los servicios. No hay respuestas correctas o incorrectas.”
- b. **Reglas:** confidencialidad, respeto, hablar de a uno, libertad para no responder.
- c. **Speech:** Su participación es voluntaria. Grabaremos solo audio para no perder detalles; puede pedir que se apague en cualquier momento. No usaremos su nombre; todo será confidencial y con códigos. El grupo durará cerca de 60 minutos. ¿Están de acuerdo en participar y autorizar la grabación?”
- d. **Consentimiento oral y de audio:** confirmar autorización de grabación.

Calentamiento breve (respuesta rápida):

¿De qué distrito vienen y a qué servicio vinieron hoy? (CRED, vacuna, consulta...)

2) Uso / No uso del EL (10–12 min)

- a. **Conocimiento del EL:** ¿Cómo se enteraron de que existe (o no) el EL en esta IPRESS?
 - o *Sondeo:* señalización, personal que informa, redes sociales, otros.
- b. **Decisión de uso:** ¿Lo usaron hoy? ¿En visitas previas? ¿Por qué sí o por qué no?
 - o *Sondeo de barrera:* ubicación, tiempo de espera, permisos, aforo, limpieza, normas.
 - o *Sondeo de facilitador:* cercanía, trato, privacidad, mobiliario, limpieza.

Mapeo: Conocimiento/uso, barreras/facilitadores → VI; Uso EL → VD.

3) Seguridad (ESCP – S) (8–10 min)

- a. Cuando piensan en seguridad del EL, ¿qué les hace sentir que es un espacio seguro para amamantar?
 - o *Sondeo:* limpieza/higiene; iluminación/ventilación; accesos/señalización; riesgos percibidos (objetos, tránsito de personas).

- b. Situación hipotética: Si llegan y el EL está limpio, con buena luz y ventilación, pero hay tránsito frecuente en la puerta, ¿se sienten seguros? ¿Qué faltaría?

Mapeo: Dimensión Seguridad (percepción) → ESCP.

4) Comodidad (ESCP – C) (8–10 min)

- a. ¿Qué comodidades consideran indispensables para poder lactar tranquila/os?
 - o *Sondeo:* silla ergonómica, mesa/apoyo, temperatura/ruido, lavamanos, insumos (toallas, folletería).
- b. Experiencia: cuenten un momento en que se sintieron cómodos usando (o intentando usar) el EL. ¿Qué ayudó?

Mapeo: Dimensión Comodidad (percepción) → ESCP.

5) Privacidad (ESCP – P) (8–10 min)

- a. ¿Qué les hace sentir privacidad al lactar en el EL?
 - o *Sondeo:* puerta/biombo/cortina, control de acceso/aforo, ubicación fuera del tránsito, interrupciones del personal.
- b. Contraste: ¿Qué cosas quitan privacidad o les incomodan?

Mapeo: Dimensión Privacidad (percepción) → ESCP.

6) Consejería y apoyo recibido / utilidad del EL (8–10 min)

- a. ¿Recibieron **consejería o apoyo** mientras usaban el EL o en el servicio hoy?
¿En qué ayudó?
 - o *Sondeo:* posicionamiento, agarre, manejo de dolor, extracción, señales de hambre.
- b. Desde su experiencia, ¿el EL les facilita amamantar durante la espera?
¿Cómo influye en su comodidad, privacidad y satisfacción con la atención recibida?

Mapeo: Consejería/apoyo → VI; Satisfacción/experiencia de uso y recomendación → VD.

7) Mejora del EL y priorización (8–10 min)

- a. Si pudieran cambiar tres cosas del EL, ¿cuáles serían y por qué? (hacer priorización rápida con puntos/pegatinas o votación a mano alzada)

- b. ¿Qué mensaje darían a otras familias para que usen el EL? ¿Y al establecimiento para que lo mejore?

Mapeo: Acciones de mejora → recomendaciones de política/gestión.

8) Cierre (2-3 min)

- Resumen (validación rápida).
- Agradecimiento + recordatorio de confidencialidad

Instrumento Cualitativo 2: Guía de entrevista individual a cuidadores de lactantes (40–50 min)

Propósito: Explorar en profundidad la experiencia de uso (o no uso) de los Espacios de Lactancia (EL), el nivel de satisfacción y recomendaciones de mejora, así como percepciones sobre seguridad, comodidad y privacidad.

Participantes: Madres, padres u otros cuidadores principales de niños/as de 0–23 meses.

Duración: 40–50 minutos.

Registro: Audio con autorización; notas de campo.

Instrumento Cualitativo 2: Guía de entrevista individual a cuidadores de lactantes

1) Apertura (5 min)

- a. Presentación personal y del objetivo de la entrevista.
- b. Speech: Gracias por su interés en participar. Esta entrevista es voluntaria; puede no responder a cualquier pregunta o retirarse en cualquier momento. Con su permiso grabaremos audio para no perder detalles, pero su nombre no será registrado. La información se usará solo para fines de investigación, de manera confidencial. ¿Acepta participar y autorizar la grabación?
- c. Explicación de voluntariedad, confidencialidad y autorización para grabar audio.
- d. Preguntas de calentamiento:
 - o ¿Podría contarme un poco sobre usted y su bebé (edad, motivo de la visita hoy)?

2) Conocimiento y uso del Espacio de Lactancia (10 min)

- a. ¿Cómo se enteró de que este establecimiento tiene un Espacio de Lactancia?
- b. ¿Qué tan fácil o difícil fue encontrarlo y usarlo?
- c. Si no lo usó, ¿qué razones tuvo para no hacerlo?

Mapeo: Uso EL (VD), conocimiento, barreras/facilitadores (VI).

3) Percepciones sobre seguridad, comodidad y privacidad (15 min)

- a. En su experiencia, ¿qué tan seguro le pareció el espacio? (limpieza, iluminación, accesos).
- b. ¿Qué tan cómodo se sintió en el espacio? (silla, temperatura, ruido, insumos).
- c. ¿Sintió que tuvo la privacidad suficiente para amamantar? (puerta, cortinas, interrupciones).
- d. ¿Podría describir un momento específico en el que se sintió particularmente seguro/cómodo/privado, o lo contrario?

Mapeo: Dimensiones ESCP → VI.

4) Consejería y apoyo recibido (5–7 min)

- a. ¿Recibió consejería o apoyo sobre lactancia mientras estaba en el EL o durante la atención en el servicio?
 - o ¿Qué temas le explicaron?
 - o ¿Le sirvió para aclarar dudas o sentirse más tranquila/o y satisfecha/o con el uso del EL y la atención recibida?

Mapeo: Consejería/apoyo → VI; Satisfacción/experiencia de uso → VD.

5) Utilidad percibida y satisfacción global con el EL (5 min)

- a. ¿En qué aspectos siente que el Espacio de Lactancia le fue útil durante la visita (comodidad, privacidad, tiempo de espera, apoyo recibido)?
- b. Para usted, ¿qué diferencia hace tener o no tener un espacio de este tipo en el establecimiento, en términos de comodidad y satisfacción con la atención?

Mapeo: Satisfacción/experiencia de uso (VD).

6) Recomendaciones y cierre (5–7 min)

- a. ¿Qué tres cambios haría al Espacio de Lactancia para que sea más útil y acogedor?
- b. ¿Qué mensaje les daría a otras madres/padres sobre usar estos espacios?
- c. ¿Qué sugerencia les daría a las autoridades de salud para mejorarlos o expandirlos?

Agradecimiento por el tiempo y recordatorio de la confidencialidad.

Instrumento Cualitativo 3: Guía de entrevista en profundidad – Personal de salud (40–60 min)

Propósito: Explorar la visión del personal de salud sobre la implementación, funcionamiento y utilidad de los Espacios de Lactancia, así como identificar barreras, facilitadores y necesidades de mejora.

Participantes:

- a. Personal de salud de establecimientos con EL (enfermeras/os, obstetras, médicos, técnicos).
- b. Personal administrativo o de apoyo vinculado al uso del EL.

Duración: 40–60 minutos.

Registro: Audio con autorización + notas de campo.

Instrumento Cualitativo 3: Guía de entrevista en profundidad – Personal de salud

1) Apertura (5 min)

- a. Presentación personal y objetivo de la entrevista.
- b. Explicar confidencialidad y voluntariedad.
- c. Speech: Esta entrevista es parte de un estudio sobre los Espacios de Lactancia en los establecimientos de salud. Su participación es voluntaria, puede retirarse en cualquier momento y no habrá consecuencias en su trabajo. Con su permiso grabaremos audio, solo para fines de análisis, y su nombre no aparecerá en ningún informe. ¿Está de acuerdo en participar y autorizar la grabación?
- d. Confirmar autorización de grabación.
- e. Pregunta inicial de calentamiento:
 - ¿Podría contarme brevemente su rol en este establecimiento y su relación con el Espacio de Lactancia?

2) Implementación y funcionamiento del EL (10–12 min)

- a. ¿Cómo se implementó este Espacio de Lactancia? (antecedentes, actores involucrados, recursos).
- b. ¿Qué protocolos o normas existen para su funcionamiento?
- c. ¿Quién es responsable de su mantenimiento y atención a las usuarias/os?

Mapeo: Variables de gestión institucional.

3) Percepciones sobre ESCP (Seguridad, Comodidad, Privacidad) (15 min)

- a. ¿Qué elementos considera que hacen al EL un lugar seguro? ¿Cuáles son los riesgos más frecuentes que han identificado?
- b. ¿Qué condiciones del EL favorecen la comodidad de las usuarias?
- c. Desde su perspectiva, ¿qué tan garantizada está la privacidad en el espacio?

Mapeo: Variables independientes – condiciones objetivas y percepciones ESCP.

4) Uso y consejería en lactancia (10 min)

- a. ¿Con qué frecuencia observa que las madres/cuidadoras usan el EL? ¿En qué momentos del día?

- b. ¿Qué tipo de consejería en lactancia brindan en este espacio? (temas, duración, responsable).
- c. ¿Qué nivel de satisfacción perciben en las familias que usan el EL? ¿Qué comentarios o quejas reciben con más frecuencia?

Mapeo: Uso y satisfacción/experiencia usuaria (VD) y apoyo/consejería (VI).

5) Barreras, facilitadores y recursos necesarios (10 min)

- a. ¿Cuáles son las principales barreras que enfrentan para mantener en funcionamiento el EL? Ej. infraestructura, recursos humanos, limpieza, horarios, normas institucionales.
- b. ¿Qué facilitadores han encontrado que ayudan a que el EL funcione mejor? Ej. apoyo de la dirección, capacitación del personal, participación de madres.
- c. ¿Qué recursos adicionales serían necesarios para fortalecer y sostener estos espacios?

Mapeo: Factores de sostenibilidad e institucionalización.

6) Recomendaciones y cierre (5 min)

- a. Si pudiera hacer tres recomendaciones para que el EL mejore, ¿cuáles serían?
- b. ¿Qué mensaje daría al MINSA u otras autoridades sobre el valor de estos espacios?

Agradecimiento por la participación.

Recordar confidencialidad y posibilidad de recibir los resultados.

Consentimiento Informado para Participar en Investigación

COMITÉ INSTITUCIONAL DE
BIOTICA DE VIA LIBRE
30-SET-2025
APROBADO
LIMA - PERÚ

Título del estudio:

Espacios de Lactancia: Evaluación de su eficacia como espacios seguros y promotores de la lactancia materna en establecimientos de salud de Lima Metropolitana, La Libertad y Piura

Investigador principal: Víctor Manolo Quispe Campos – DNI 25785198 – contacto 957797096

Institución ejecutora: Save the Children Perú

Versión: 01

Fecha: [Fecha de aprobación por el CIB]

1. Introducción

La lactancia materna es una de las prácticas más efectivas para proteger la salud de niñas, niños y madres. Comenzar a amamantar de manera temprana, mantener la lactancia exclusiva durante los primeros seis meses y prolongarla hasta los dos años o más ayuda a prevenir enfermedades, favorece el desarrollo cognitivo y protege a las madres frente a problemas de salud como el cáncer o la diabetes. Sin embargo, aún existen muchas dificultades para que todas las familias puedan ejercer este derecho. A nivel mundial, menos de la mitad de los bebés reciben lactancia exclusiva durante los primeros seis meses, y en el Perú la cobertura ha disminuido en los últimos años, siendo menor en las zonas urbanas. Esta situación se agrava por limitaciones en los servicios de salud, como la falta de espacios adecuados para amamantar, la escasa consejería o la influencia de sucedáneos de la leche materna.

Frente a este escenario, los Espacios de Lactancia en los establecimientos de salud buscan ofrecer ambientes seguros, cómodos y privados que faciliten la práctica de la lactancia durante la espera de atención. Aunque ya existen normas nacionales e internacionales que establecen cómo deben funcionar estos espacios, todavía hay poca evidencia sobre su eficacia real en la experiencia de las familias y en la promoción de la lactancia, sobre todo en contextos urbanos. Por ello, este estudio evaluará los Espacios de Lactancia en Lima Metropolitana, La Libertad y Piura, con el propósito de conocer si cumplen con los estándares de seguridad, comodidad y privacidad, y si realmente ayudan a fortalecer la lactancia materna. Queremos invitarle a participar en esta investigación: su colaboración es completamente voluntaria y puede retirarse en cualquier momento, sin que esto afecte la atención que recibe en los servicios de salud.

2. Justificación

La lactancia materna es una de las intervenciones más costo-efectivas para reducir la morbilidad y mortalidad infantil, favoreciendo además el desarrollo cognitivo y la salud materna frente a enfermedades crónicas (Victora et al., 2016; WHO, 2023). Por ello, la OMS y UNICEF recomiendan la lactancia materna exclusiva durante los seis primeros meses y su continuación hasta los dos años o más, junto con alimentación complementaria adecuada. Sin embargo, un obstáculo recurrente es la falta de espacios seguros, cómodos y privados para amamantar o extraer leche en los establecimientos de salud, brecha que no ha sido resuelta plenamente por la normativa nacional vigente ni por su aplicación limitada a contextos laborales.

En este marco, evaluar la eficacia operativa de los Espacios de Lactancia en servicios de salud permitirá generar evidencia sobre su capacidad para superar estas barreras y promover la continuidad de la lactancia materna durante la espera de atención. Esta investigación se inspira también en lineamientos internacionales, como la Operational Guidance on Infant and Young Child Feeding in Emergencies (OG-IFE v3), que recomiendan habilitar espacios protectores para la lactancia en contextos de vulnerabilidad y movilidad, especialmente pertinentes en los territorios priorizados.

Los resultados del estudio contribuirán a definir estándares técnicos y protocolos verificables para la adecuada implementación de los Espacios de Lactancia, aportar evidencia estratégica para orientar decisiones de escalamiento programático con criterios de equidad y derechos, y generar insumos prácticos

para fortalecer políticas públicas. De este modo, la investigación busca no solo documentar la pertinencia de los Espacios de Lactancia como estrategia de apoyo a la lactancia en entornos urbanos, sino también consolidar a los servicios de salud como espacios protectores y promotores de la equidad en salud materno-infantil.

3. Objetivos

Evaluar la eficacia operativa de los “Espacios de Lactancia” implementados en establecimientos de salud de Lima Metropolitana, La Libertad y Piura en 2025, con el fin de garantizar condiciones seguras, cómodas y privadas durante la permanencia en el establecimiento de salud y valorar su contribución a la promoción y práctica de la lactancia materna.

4. Número de participantes y duración

Se estima la participación de 392 cuidadores en encuestas, 20 entrevistas a profundidad con personal de salud y 6 grupos focales con cuidadores. La duración del estudio será de tres meses (octubre–diciembre 2025). Cada participación durará entre 20 y 60 minutos.

5. Procedimientos

Si acepta participar, se le pedirá responder una encuesta, y en algunos casos, participar en una entrevista o grupo focal. Estas actividades podrán ser grabadas en audio solo con su autorización.

No aplica: Este estudio no incluye medicamentos, tratamientos clínicos, procedimientos invasivos ni comparaciones con placebo.

No aplica: El estudio no contempla la recolección de muestras biológicas.

6. Riesgos

Los riesgos son mínimos: cansancio, incomodidad al responder preguntas o al compartir experiencias. Podrá detener la entrevista en cualquier momento. Si presenta incomodidad, será derivado a servicios de apoyo si lo desea.

7. Beneficios

Usted no recibirá beneficios económicos directos, pero su participación contribuirá a mejorar los servicios de salud y la promoción de la lactancia materna, beneficiando a otras madres, cuidadores y familias.

8. Alternativas a la participación

La no participación en el estudio no tendrá ningún efecto en la atención que recibe en el establecimiento de salud.

9. Compensación

No se ofrecerán pagos. En el caso de grupos focales, se entregará un refrigerio como muestra de agradecimiento por su tiempo.

10. Eventos adversos y responsabilidad

En caso de que su participación genere algún malestar físico o psicológico que requiera atención, será derivado al establecimiento de salud correspondiente para recibir la asistencia necesaria. Además, si en cualquier momento necesita apoyo adicional, como acompañamiento psicológico, orientación legal, o apoyo social o médico, contamos con un directorio de servicios profesionales disponibles en la comunidad, el cual estaremos encantados de compartir con usted.

11. Confidencialidad

Toda la información será confidencial y anonimizada. Se asignará un código a cada participante. Las grabaciones de audio serán transcritas y eliminadas al concluir el estudio. Los datos estarán protegidos con contraseña en servidores seguros.

No aplica: El estudio no involucra análisis genético ni almacenamiento de muestras en biobancos.

12. Manejo de grabaciones

Las entrevistas y grupos focales podrán ser grabados en audio con su autorización. Estas grabaciones se usarán únicamente para análisis, no serán compartidas y se destruirán tras la transcripción.

13. Acceso a resultados

Al finalizar, se elaborará un informe técnico para autoridades de salud y un resumen accesible para los participantes, en formato infográfico y con lenguaje sencillo.

14. Costos

Usted no tendrá que pagar nada por participar.

15. Voluntariedad

Su participación es completamente voluntaria. Puede retirarse en cualquier momento sin consecuencias ni afectación a la atención médica.

16. Derecho a retirar datos

Si decide retirarse, podrá solicitar que la información que brindó no sea utilizada, siempre que aún no haya sido anonimizada en la base de datos.

17. Publicación de resultados

Los resultados serán publicados de manera agregada, sin identificadores personales, y podrán ser utilizados para informes públicos, artículos científicos y documentos de política pública.

No aplica: No corresponde acceso post - estudio a ningún producto, al no existir intervención experimental.

18. Protección legal

El estudio cumple con la Declaración de Helsinki y con la Ley de Protección de Datos Personales N.º 29733 del Perú.

19. Contactos

- **Investigador principal:** Alejandro Fernando Cisneros Davila – teléfono: 964576394 – correo: fernando.cisneros@savethechildren.org
- **Comité Institucional de Bioética (CIB):**

20. Aprobación del Comité de Ética

Este protocolo y el presente consentimiento informado han sido revisados y aprobados por el Comité Institucional de Bioética.

21. Consentimiento del participante

He leído y comprendido la información. He tenido la oportunidad de hacer preguntas, y todas fueron respondidas. Entiendo que mi participación es voluntaria y que puedo retirarme en cualquier momento sin consecuencias.

Firma del participante: _____

Nombre completo: _____

DNI: _____ Fecha: _____

Firma del investigador que informa: _____

Nombre completo: _____

Fecha: _____

22. Testigo independiente (cuando corresponda)

En caso de que el participante no sepa leer o escribir, se contará con la firma de un testigo independiente.

Firma del testigo: _____

Nombre completo: _____

DNI: _____ Fecha: _____

Información sobre el Comité Institucional de Bioética:

Si usted tiene alguna pregunta sobre sus derechos como participante o sobre la ética del estudio, puede contactarse con la Dra. María Luisa Cairampoma Gago, Presidenta del Comité Institucional de Bioética (CIB) de VÍA LIBRE, al teléfono 203-9900 de lunes a viernes de 09 a 18 horas o acercarse al Jr. Paraguay 490, Cercado de Lima, Correo electrónico: comitebioetica@vialibre.org.pe

Un Comité de Ética está conformado por un grupo de personas de ámbitos científicos y no científicos que realizan una revisión inicial y permanente del estudio de investigación para mantener la seguridad y proteger los derechos de los(as) participantes.

SCI-448-2025

Lima, 25 de noviembre de 2025

Doctora

Karina Ivonne Colmenares Otiniano

Directora General

Dirección de Redes Integradas de Salud Lima Centro – DIRIS LC

Presente.–

Asunto: Presentación de investigador y solicitud de colaboración para estudio de Espacios de Lactancia para la primera infancia.

De mi especial consideración:

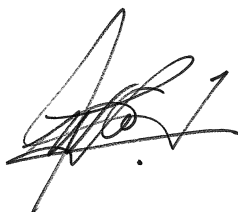
Por medio de la presente, yo, William Campbell Falconí, identificado con DNI 10302881, en calidad de Director País de Save the Children en Perú, tengo el agrado de presentar a Víctor Manolo Quispe Campos, identificado con DNI N° 25785198, quien se desempeña como Especialista de Monitoreo, Evaluación, Rendición de Cuentas y Aprendizajes de la institución y es responsable del proyecto de investigación titulado "Espacios de Lactancia: Evaluación de su eficacia como espacios seguros y promotores de la lactancia materna en contextos humanitarios urbanos en Lima, La Libertad y Piura, 2025".

Nuestra institución autoriza y respalda la ejecución de dicho estudio, el cual se orienta a evaluar la eficacia operativa de los Espacios de Lactancia (EL) en servicios de salud, lo que permitirá generar evidencia aplicada sobre su capacidad de resolver estas barreras y promover la continuidad de la Lactancia Materna durante la espera de atención, en las regiones de Lima, La Libertad y Piura durante el año 2025, en coordinación con los establecimientos de salud que corresponda.

Consideramos que los resultados del estudio aportarán evidencia relevante para mejorar la gestión y la calidad de los servicios de salud dirigidos a la primera infancia, por lo que agradecemos el apoyo que la DIRIS Lima Centro y sus establecimientos puedan brindar al equipo investigador para el desarrollo de las actividades previstas.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente,



William Campbell Falconí

Director País

Save the Children en Perú

Nº de Ingreso: **Nº 12992 (2025 a)**

Nombre oficial de la Investigación:

“Espacios de Lactancia: Evaluación de su eficacia como espacios seguros y promotores de la lactancia materna en contextos humanitarios urbanos de Lima Metropolitana, La Libertad y Piura, 2025”.

Fecha de Presentación Virtual: 24 de setiembre de 2025
Fecha de Sesión Virtual: 30 de setiembre de 2025
Investigador Principal: Lic. Víctor Manolo Quispe Campos
Institución de Investigación: Save the Children Perú

Miembros participantes en la Sesión Virtual:

Número de miembros del quórum: cinco (05)

Preside: Cairampoma Gago, María Luisa (Méd. Cirujano)

Miembros que participaron en la sesión: **01.-** Pérez Ramírez, Luis (Administrador); **02.-** Mello de la Cruz, Orlando (Abogado); **03.-** Torres Ramírez, Patricia (Miembro de la Comunidad); **04.-** Pajuelo Mendoza, Miriam (Méd. en Medicina Familiar y Comunitaria); **05.-** Gutiérrez Flores, Martín César (Téc. Médico); **06.-** Haro Varas, Juan Carlos (Méd. Oncólogo); **07.-** Flórez Granda, Alberto (Méd. Infectólogo); **08.-** Ortega Orihuela, Sara (Psicóloga); y **09.-** Quiroz Gonzales, Carla (Méd. Pediatra).

La presidenta del Comité consultó si alguno de los miembros presentes tenía algún conflicto de interés para participar en la evaluación del presente estudio observacional. Teniendo como respuesta que ninguno de los miembros presentes tiene conflicto de interés para participar.

Documentos evaluados:

- Carta con fecha 24 de setiembre de 2025. Investigador solicita evaluación inicial del estudio y presenta los siguientes documentos:
 - ✓ Módulo Nº 3: Solicitud al Comité Institucional de Bioética de Vía Libre para la Evaluación de Estudios Sociales, Observacionales y de Farmacología con Seres Humanos.
 - ✓ Protocolo de investigación (español).
 - ✓ Consentimiento Informado para Participar en Investigación. Versión: 01.
 - ✓ Guía para la elaboración del formato básico para protocolos de investigación de estudios observacionales o de riesgo mínimo a presentar al CIB.
 - ✓ Instrumento Cualitativo 1: Guía de Grupo Focal con cuidadores de lactantes
 - ✓ Instrumento Cualitativo 2: Guía de entrevista individual a cuidadores de lactantes
 - ✓ Instrumento Cualitativo 3: Guía de entrevista en profundidad – Personal de salud
 - ✓ Instrumento 1: Encuesta estructurada a cuidadores de lactantes
 - ✓ Instrumento 2: Lista de Chequeo de Observación del Espacio de Lactancia
 - ✓ Curriculum Vitae del Lic. Quispe e Investigadores Asociados.
 - ✓ Certificado de Buenas Prácticas Clínicas del Lic. Quispe e Investigadores Asociados.
 - ✓ Certificado de Ética en la Investigación del Lic. Quispe e Investigadores Asociados.
 - ✓ Declaración de Conflicto de Interés del Lic. Quispe e Investigadores Asociados.
 - ✓ Declaración Jurada de Confidencialidad del Lic. Quispe e Investigadores Asociados.
 - ✓ Declaración Jurada de Horas de Dedicación a la Investigación del Lic. Quispe e Investigadores Asociados.

COMITÉ INSTITUCIONAL DE
BIOÉTICA DE VÍA LIBRE

30-SET-2025

LIMA - PERÚ

Resultado de la Evaluación: luego de haber revisado los documentos presentados y evaluado los aspectos señalados, el Comité Institucional de Bioética de Vía Libre da por **APROBADO** la realización del estudio observacional por UN AÑO (del 30 de setiembre de 2025 al 29 de setiembre de 2026).

El presente estudio observacional solo podrá realizarse en la Institución *Save the Children Perú*, bajo la conducción del Investigador Principal **Lic. Víctor Manolo Quispe Campos**, de acuerdo con el protocolo aprobado por el Comité Institucional de Bioética de Vía Libre.

El Comité solicita al Lic. Quispe presentar la “Declaración Jurada de Compromiso del IP e Investigadores Asociados”.

Documentos aprobados:

- ✓ Módulo N° 3: Solicitud al Comité Institucional de Bioética de Vía Libre para la Evaluación de Estudios Sociales, Observacionales y de Farmacología con Seres Humanos.
- ✓ Protocolo de investigación (español).
- ✓ Consentimiento Informado para Participar en Investigación. Versión: 01.
- ✓ Guía para la elaboración del formato básico para protocolos de investigación de estudios observacionales o de riesgo mínimo a presentar al CIB.
- ✓ Instrumento Cualitativo 1: Guía de Grupo Focal con cuidadores de lactantes
- ✓ Instrumento Cualitativo 2: Guía de entrevista individual a cuidadores de lactantes
- ✓ Instrumento Cualitativo 3: Guía de entrevista en profundidad – Personal de salud
- ✓ Instrumento 1: Encuesta estructurada a cuidadores de lactantes
- ✓ Instrumento 2: Lista de Chequeo de Observación del Espacio de Lactancia

Documentos archivados:

- ✓ Currículum Vitae del Lic. Quispe e Investigadores Asociados.
- ✓ Certificado de Buenas Prácticas Clínicas del Lic. Quispe e Investigadores Asociados.
- ✓ Certificado de Ética en la Investigación del Lic. Quispe e Investigadores Asociados.
- ✓ Declaración de Conflicto de Interés del Lic. Quispe e Investigadores Asociados.
- ✓ Declaración Jurada de Confidencialidad del Lic. Quispe e Investigadores Asociados.
- ✓ Declaración Jurada de Horas de Dedicación a la Investigación del Lic. Quispe e Investigadores Asociados.

Tiempo de validez de la aprobación del Comité:

- UN AÑO, a partir del 30 de setiembre de 2025 al 29 de setiembre de 2026.

Documentos exigidos:

- Informe de avance semestral y anual del estudio observacional.
- Informe final de los resultados del estudio observacional.
- Solicitar al Comité la renovación anual del estudio observacional, por lo menos con un mes previo al vencimiento de la aprobación.

Registro: Libro de Actas CIB, Acta del 30 de setiembre de 2025

Firmada: 30 de setiembre de 2025

MARÍA LUISA CAIRAMPOMA GAGO
Comité Institucional de Bioética de Vía Libre
Presidenta

COMITÉ INSTITUCIONAL DE BIOÉTICA DE VÍA LIBRE
30-SET-2025
LIMA - PERÚ